PLANO DE ANÚNCIOS PARA CONSULTÓRIO · VERSÃO DE 04/11/2026

Como eu faria seus anúncios de Ortopedia

Plano para quem tem consultório próprio, continuando o carrossel: a conta, a verba, as campanhas, os criativos e o combinado com a recepção, para ortopedia.

1 A conta da consulta, antes de qualquer anúncio

Clínica não compra conversa. Clínica compra paciente sentado na cadeira. Por isso a primeira coisa que eu faria é esta conta, com os seus números.

1 O valor da consulta que você cobra

2 menos o que ela custa para você (equipe, aluguel, imposto) = o que sobra

3 Valor da consulta ÷ o que sobra = quanto cada R$ 1 de anúncio precisa voltar para empatar

EXEMPLO, NÃO É NÚMERO SEU

Consulta de R$ 400, sobram R$ 200	**cada R$ 1 precisa voltar R$ 2**
Com 25% de desconto: consulta de R$ 300, sobram R$ 100	**cada R$ 1 precisa voltar R$ 3**
R$ 1.000 de verba a R$ 10 por conversa = 100 conversas	**16 consultas realizadas, R$ 6.400 em consultas de R$ 400 (se 40% agendam e 40% comparecem)**

Seus números: consulta R$ _____ · sobra R$ _____ · cada R$ 1 precisa voltar R$ _____

Os 40% são benchmark de mercado (funil 40/40/40, do método de Pedro Sobral): de 100 conversas, 40 agendam, 16 comparecem e 4 fecham tratamento ou procedimento. Serve só para abrir a conversa. Com 60 a 90 dias de campanha, vale o número da sua conta, e só ele.

O que entra na conta nesta especialidade

Ortopedia tem dois tipos de paciente na agenda: a dor aguda, de decisão rápida, e o caso que pode virar infiltração, fisioterapia, exame de imagem ou cirurgia. Separe na conta o que fecha no consultório do que você encaminha para outro serviço.

2 Onde colocar a verba

Google
vai quem tem urgência. O paciente já está procurando e escolhe quem aparece e responde primeiro.

Meta (Instagram e Facebook)
vai quem tem ticket e precisa de confiança. Antes de vender o preço, eu preciso vender o médico.

Notoriedade
médico já conhecido na cidade rende no Google mesmo com ticket alto.

COMBO: GOOGLE FORTE

Torção, coluna que travou e ombro que não levanta viram busca no Google no mesmo dia. O paciente de ticket alto, como joelho com desgaste, ombro crônico ou quadril, pesquisa por meses e precisa ver você antes de decidir. Google para a dor que não espera. Meta para o caso que pode virar tratamento longo ou cirurgia.

A fatia exata de cada lado eu só fecho com 60 a 90 dias de dado da sua conta. Aqui está o ponto de partida.

3 As 3 campanhas do Google

Volume de busca e custo por clique eu não medi para a sua cidade. Tudo abaixo é para testar, não é dado. Eu começaria em correspondência exata, e abriria para frase só se a exata não gastar a verba.

1. Nome do médico

Quem já ouviu falar de você e vai conferir. Teto de R$ 30 por dia.

- dr. / dra. [seu nome]
- [seu nome] [cidade]
- [nome da clínica] [cidade]

2. Especialidade + cidade

Quem já sabe qual médico procura e está comparando.

- ortopedista [cidade]
- ortopedista particular [cidade]
- consulta com ortopedista [cidade]
- ortopedista joelho [cidade]
- ortopedista coluna [cidade]
- ortopedista ombro [cidade]

3. Sintoma

Quem ainda não sabe qual médico resolve. Ele pesquisa o que sente.

- dor no joelho ao subir escada
- dor lombar que não passa
- dor no ombro ao levantar o braço
- torci o tornozelo e inchou
- dor no quadril ao andar
- formigamento no braço
- dor no calcanhar ao acordar

Negativar de saída: "exercício em casa", "pomada", "fisioterapia (se você não oferece)", "grátis", "SUS", "curso".

> Use subárea no termo (joelho, coluna, ombro) só se você realmente atende aquela subárea. Termo de subárea que você não atende traz clique que não vira consulta.

Destino do clique: o WhatsApp da recepção ou uma página curta com preço, forma de pagamento e endereço. O clique no botão de WhatsApp é a conversão que eu marco.

4 Público e sequência na Meta

Público

Adultos da cidade e do raio. O criativo filtra: o corredor de fim de semana, quem trabalha sentado e tem a coluna travada, quem convive com joelho ruim há anos e já adiou a consulta.

MÊS 1

70% no topo

70% da verba vai para quem ainda não conhece o seu nome, com vídeo que tira dúvida. Os 30% restantes vão para o anúncio de consulta, com preço e forma de pagamento, para quem já viu o vídeo.

Os dois primeiros vídeos do mês são a ressonância antes da consulta e o joelho que dói depois do fim de semana de corrida.

MÊS 2 EM DIANTE

60% em remarketing

60% da verba vai para quem já conhece você: quem chamou no WhatsApp (180 dias), quem visitou o site (90 dias) e quem assistiu aos vídeos (30 dias). O topo continua rodando com o resto.

Quem chamou e não marcou vê o vídeo do que acontece na primeira consulta de ortopedia, com valor. Quem assistiu ao vídeo de joelho vê o anúncio de consulta com horários.

Eu não mexo numa campanha em menos de 72 horas e olho o mês, não o dia. Eu reporto duas medidas lado a lado: conversa iniciada e segunda mensagem enviada. Só a primeira infla.

5 3 ângulos de criativo

Cada um filtra um paciente. Atenção sem filtro traz curioso, e curioso encarece a conversa.

Ressonância antes da consulta?

"Ressonância antes de consultar o ortopedista: precisa mesmo?"

Vídeo do médico. A dúvida é real e filtra quem está decidindo por onde começar.

Corredor de fim de semana

"Você corre sábado e domingo e o joelho avisa na segunda? Eu explico por onde começo."

Reel com gancho visual de corrida. Filtra o amador que quer continuar correndo.

A dor que melhora e volta

"Dor no joelho que melhora com remédio e volta em duas semanas: esta é a pergunta que eu faria."

Vídeo curto, sem diagnóstico e sem promessa. Filtra o paciente crônico que adia há tempo.

6 5 dúvidas de paciente para virar conteúdo

1. "Preciso fazer ressonância ou raio-X antes de consultar?"
2. "Dor no joelho é desgaste? Vou precisar de cirurgia?"
3. "Dor nas costas: eu repouso ou me mexo?"
4. "Infiltração dói? Faz mal?"
5. "Quanto tempo leva para voltar a correr depois de uma torção?"

Cada dúvida vira um vídeo ou carrossel. Toda resposta com número ou critério precisa de fonte que você possa citar. Sem fonte, tira o número e fica o raciocínio.

7 O combinado com a recepção

Eu trabalho com 20 minutos como limite de resposta: quem tem dor costuma chamar mais de um consultório e fecha com quem responde primeiro e já oferece horário.

Quem responde	Em quanto tempo	O que a IA pode fazer sozinha

A primeira resposta, por escrito

Repetir o que a pessoa pediu, informar o valor e oferecer dois dias e horários. Cadastro e reserva vêm depois da escolha.

Pergunta inicial: "Onde dói, desde quando e foi uma pancada ou veio aos poucos?"

Urgência e encaixe

Trauma recente com deformidade, não consegue apoiar ou mexer, ou dormência: a recepção não marca para a semana que vem. Orienta pronto-socorro.

Peça que o paciente traga os exames de imagem que já fez. Isso encurta a consulta e evita pedir de novo.

Automático pode ser o aviso de recebimento, a pergunta inicial e o lembrete de horário. Preço, horário e qualquer orientação de saúde saem de uma pessoa ou de um texto que você já aprovou.

8 O que eu NÃO faria, pelo conselho

Base: Resolução CFM 2.336/2023, a vigente. Ela permite informar preço, forma de pagamento e desconto. Continua fora:

- Promessa de resultado, em qualquer forma.
- Antes e depois.
- Nota, estrela ou print de avaliação.
- Chamar alguém de especialista sem o RQE registrado.
- Escassez que não existe. "Últimos horários" só se a agenda estiver fechando de verdade.

Nesta especialidade, o risco mais comum

- Prometer evitar cirurgia ou curar artrose, hérnia ou tendinite.
- Antes e depois de exame, de postura ou de recuperação.
- Print de avaliação, com nota ou estrela, em anúncio.
- Colocar "ortopedista" ou "especialista em coluna, joelho ou ombro" sem o RQE. Sem ele, use "médico" e descreva a área em que atende.

Antes de subir qualquer anúncio, o texto passa por revisão. Este plano não substitui a leitura da resolução pelo responsável técnico.

E antes da conversa chegar?

O plano cuida do anúncio e da recepção. O Raio-X olha o passo anterior: como o seu consultório aparece hoje no Google e na IA. Leva poucos minutos.

Fazer o Raio-X do meu consultório